

APÊNDICE A – FORMULÁRIO PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO DE LEITOS DE UTI

FORMULÁRIO PROTOCOLO DE LIBERAÇÃO DE LEITOS DE UTI



SES
Secretaria de Estado
da Saúde

Data da Avaliação: ____ / ____ / ____

Hora da Avaliação: ____ : ____

Nome do Paciente: _____ DN: ____ / ____ / ____

Gênero: ☐ Masculino ☐ Feminino ☐ Outro:

Idade: _____ ECOG: _____

Diagnóstico Principal: _____

Hospital de origem: _____

Médico Assistente: _____ C.R.M.: _____

COMORBIDADES E CRITÉRIOS DE RISCO

☐ Diabetes	☐ Hipertensão	☐ Sedentarismo	☐ Obesidade (IMC >30)	☐ Tabagismo e/ou alcoolismo	☐ Dislipidemia	☐ DAOP
☐ AIT	☐ História familiar de DAC precoce	☐ Câncer prévio	☐ IAM prévio	☐ Fibrilação atrial	☐ RVM prévia	☐ AVC

CRITÉRIOS CLÍNICOS PARA INTERNAÇÃO EM UTI

SIM

NÃO

SUPOORTE VENTILATÓRIO

Necessidade de ventilação mecânica invasiva		
Insuficiência respiratória aguda com necessidade de suporte ventilatório		
Hipoxemia grave (PaO ₂) < 60mmHg em ar ambiente ou relação PaO ₂ /FiO ₂ < 200)		
Hipercapnia com pH < 7,25 apesar de medidas não invasivas		

INSTABILIDADE HEMODINÂMICA

Necessidade de uso contínuo de drogas vasoativas		
Hipotensão refratária (PAS < 90 mmHg ou PAM < 65 mmHg após reposição volêmica)		
Taquicardia sustentada (> 150 bpm) associada a instabilidade clínica		
Arritmias ventriculares graves ou choque cardiogênico		



DISFUNÇÃO RENAL E METABÓLICA		
Necessidade de terapia de substituição renal contínua (hemodiálise ou diálise peritoneal)		
Distúrbios hidroeletrólíticos graves não corrigíveis em ambiente não intensivo		
Acidose metabólica grave (pH < 7,2) não responsiva à terapia habitual		
SEPSE E DISFUNÇÃO ORGÂNICA		
Sepse com necessidade de suporte hemodinâmico		
Choque séptico (hipotensão mantida apesar de reposição volêmica adequada)		
Lactato sérico > 4 mmol/L		
Necessidade de antibioticoterapia venosa de amplo espectro com vigilância intensiva		
CONDIÇÕES NEUROLÓGICAS CRÍTICAS		
Rebaixamento do nível de consciência (Glasgow ≤ 8)		
Convulsões persistentes ou status epilepticus		
AVC hemorrágico ou isquêmico extenso com necessidade de monitoramento intensivo		
Hipertensão intracraniana grave com sinais clínicos de herniação		
OUTRAS SITUAÇÕES CLÍNICAS GRAVES		
Pós-operatório imediato de cirurgia de grande porte com alto risco de complicações		
Politraumatismo grave com instabilidade clínica		
Queimaduras extensas com necessidade de suporte intensivo		
Intoxicações graves com necessidade de monitoramento contínuo		
Pacientes imunossuprimidos com deterioração clínica aguda		

Assinatura e carimbo: _____

APÊNDICE B – EASTERN COOPERATIVE ONCOLOGY GROUP (ECOG)

EASTERN COOPERATIVE ONCOLOGY GROUP (ECOG)

A escala *Eastern Cooperative Oncology Group* (ECOG) avalia o impacto da doença nas atividades diárias do paciente, com pontuações que variam de zero a cinco pontos. A pontuação cinco indica morte, enquanto a pontuação zero significa que o paciente está totalmente ativo.

- ◇ 0 – Atividade habitual sem restrições.
- ◇ 1 – Apresenta sintomas da doença, mas consegue se mover e realizar suas atividades cotidianas.
- ◇ 2 – Fora do leito mais de 50% do tempo.
- ◇ 3 – No leito mais de 50% do tempo, necessitando de cuidados mais intensivos.
- ◇ 4 – Restrito ao leito, com grande dependência.
- ◇ 5 – Óbito.

Tabela 1 - *Eastern Cooperative Oncology Group* (ECOG).

Valor	Descrição da capacidade funcional	Equivalência KPS
0	Atividade normal	90 - 100%
1	Sintomas da doença, mas deambula e leva seu dia a dia normal	70 - 80%
2	Fora do leito mais de 50% do tempo	50 - 60%
3	No leito mais de 50% do tempo, carente de cuidados mais intensivos	30 - 40%
4	Restrito ao leito	20 - 10%
5	Óbito	0

Fonte: Oken *et al.* (1982) *apud* INCA (2022).